

Una persona autista en su equipo de enfermería residencial

Para el personal de enfermería de residencias y centros de cuidados residenciales — apoyar a una persona autista en cuidados asistidos / residenciales / apoyo intensivo (cualquier edad).

la idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de una persona se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos. Para una persona autista en apoyo intensivo, los entornos de enfermería y cuidados son a menudo los **más difíciles de todos**: hostiles sensorialmente, disruptores de la rutina, llenos de contacto y demandas impredecibles. Muchos se comunican sin habla y pueden no registrar o reportar la dolor hasta que es severa. Las prioridades de enfermería son claras: leer **todo comportamiento como una comunicación sobre una necesidad no satisfecha**, investigar la dolor y las causas físicas en primer lugar, proteger las rutinas y la voluntad, y nunca suponer la incapacidad a partir de una comunicación atypica.

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
«Comportamiento desafiante», autolesiones, rechazo	Abrumadoramente comunicación sobre una necesidad no satisfecha — dolor, miedo, sobrecarga, rutina perdida
No reporta la dolor; colapso súbito / presentación tardía	Diferencias de intérocepción — las señales internas pueden no registrarse hasta que son severas
Meltdown o bloqueo (<i>shutdown</i>) durante los cuidados	Respuesta involuntaria a la sobrecarga — <i>no</i> es agresión o falta de observancia
Retiro cuando cambian los objetos, el orden o el personal	Las rutinas y las posesiones son anclas de identidad y seguridad
Sin habla fiable; depende de la CAA o un acompañante	Comunicación atypica ≠ falta de capacidad o comprensión

Intente esto

- **Investigue la dolor y las causas físicas en primer lugar** para cualquier nueva angustia — la constipación, la dolor dental, la infección, el equipo mal ajustado son culpables comunes y ocultos.
- **Bâtissez los cuidados alrededor de la previsibilidad**: personal constante, misma secuencia, horarios visuales, aviso previo de cada cambio.
- **Reduzca la carga sensorial** — sala tranquila, luz tenue, reduzca los pitidos y los olores fuertes; preserve los objetos, intereses y rutinas de la persona.
- **Utilice la toma de decisiones asistida** y un perfil de comunicación/sensorial individualizado; consulte al acompañante de confianza.
- **Tenga un plan tranquilo y escrito para el meltdown/shutdown**: reduzca la estimulación, asegure la seguridad, dé tiempo y espacio — no contenga.

Evite esto

- Etiquetar la angustia como «comportamental» antes de excluir la dolor y la sobrecarga.

- Utilizar la contención o la *sédation* como primera respuesta al meltdown/shutdown.
- Eliminar rutinas, objetos o intereses «por su propio bien», o suponer la falta de capacidad a partir de una comunicación atípica.

Cuándo buscar más apoyo

Trate la **angustia nueva o creciente** como un señal de alarma médica hasta que la dolor, la infección, la constipación, los problemas dentales y las causas sensoriales/ambientales sean excluidos. Déjiste el **burnout autístico** bajo carga crónica. Involucre a **equipos especialistas en autismo/discapacidad intelectual** y ortopedia/logopedia (CAA). Guarde un «pasaporte salud/hospitalario» listo para cualquier admisión.

Nota sobre el género

Las mujeres en apoyo intensivo están especialmente sub-identificadas y mal atendidas; su angustia es aún más a menudo mal interpretada. Aplique la misma rigurosidad para excluir la dolor y la sobrecarga independientemente de la presentación o el método de comunicación.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 3.5 & 4), la **Guía para la familia** (Parte 5, residencias y hospitales) y la brève sobre el **Monotropismo**. Utiliza el lenguaje de identidad primero. **Informativo — no es un herramienta de diagnóstico**. Adáptelo al individuo.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, interoception/pain); Autism Society (2025, meltdowns/shutdowns); AASPIRE AHAT. Las citas completas están en los borradores fuente.